

경희홍익한의원

8월 8일 리포트와 8월 말 실적 비교 분석

기준 A 2026-07-10 ~ 2026-08-08 · 기준 B 2026-07-30 ~ 2026-08-28 · 각 진료일 25일
부산 사하구 다대로 698, 3층 · 허진혁 원장 · 김상준 원장 · 작성일 2026-08-29

진료환자 일평균 36.1명 이전 30일 대비 -15.3%	초진 일평균 4.2명 8/8 리포트 대비 -14.3%	성숙 코호트 재진율 85.3% 34명 중 29명	총진료비 5,037만원 이전 30일 대비 -17.2%
--	--	---	--

판단이 바뀌었습니다

8월 8일 리포트는 일평균 진료건수 40.2건을 현재 경쟁 조건의 정상 범위로 해석했습니다. 그러나 8월 말 관측창에서는 진료건수 36.5건, 진료환자 36.1명으로 내려왔습니다. 정상 목표로 제시했던 42~45명보다 13~20% 낮아, 이제는 단순한 정상화만으로 설명하기 어렵습니다.

핵심 결론	치료 단가와 초진의 첫 재방문은 방어되고 있습니다. 매출 하락의 주원인은 가격이 아니라 초진 유입 감소와 전체 진료량 감소입니다. 다음 30일의 우선순위는 단가 인상이 아니라 초진 회복, 2회차에서 3회차 전환, 원장별 유지력 격차 축소입니다.
-------	--

비교 해석 주의

두 30일 구간은 2026년 7월 30일부터 8월 8일까지 10일이 겹칩니다. 따라서 통계적으로 완전히 독립된 전후 비교가 아니라, 관측창을 20일 뒤로 이동했을 때 새로 드러난 신호를 비교합니다. 최신 실적의 직전 30일 비교는 별도로 독립된 기간입니다.

01 환자량과 초진 · 정상 범위 아래로 하락

8월 8일 리포트의 핵심 전제였던 ‘현재 경쟁 조건의 정상 목표 42~45건/일’과 비교하면 최신 진료건수 36.5건은 명확히 낮습니다. 진료일은 모두 25일이므로 휴진 증가가 원인은 아닙니다.

지표	8/8 리포트 창	8월 말 최신	변화	판정
진료건수 일평균	40.2	36.5	-9.2%	경고
진료환자 일평균	별도 미표시	36.1	직전 42.6 대비 -15.3%	경고
초진 일평균	4.9	4.2	-14.3%	경고
현재 경쟁조건 목표	42~45	36.5	목표 하단 대비 -13.1%	미달

월간 장기 흐름



2025년 9월 48.8명에서 2026년 8월 35.8명으로 약 27% 낮아졌습니다. 전년 동기 47.3명과 비교한 최신 30일도 23.7% 낮습니다. 폭염이 초진을 미루게 했을 가능성은 있지만, 최근 90일 39.9명과 올해 누계 40.8명보다도 낮아 계절 요인만으로 설명하기 어렵습니다.

감소의 파급

초진은 이전 독립 30일보다 하루 0.8명, 25일 기준 약 20명 줄었습니다. 성숙 초진 1명이 21일 동안 평균 4회의 후속 방문을 만든다는 점을 적용하면, 이 초진 공백은 이후 약 80회의 후속 진료 기회 감소로 이어질 수 있습니다. 지금의 전체 환자 감소에는 현재 초진 부족과 과거 초진 부족의 시차 효과가 함께 섞여 있습니다.

8월 말 판정

‘2024년 반사이익의 정상화’라는 기존 설명은 장기 맥락으로 유효합니다. 다만 현재 36명대는 같은 경쟁 밀도에서 제시했던 정상선 42~45보다 낮으므로, 별도의 단기 유입 저하 또는 운영상 이탈을 확인해야 합니다.

02 전환 퍼널 · 재진보다 2회차 이후가 과제

8월 8일에는 21일 추적 미완 때문에 재진율과 삼진율 판단을 유보했습니다. 최신 자료에서는 추적 완료 초진 34명이 확보되어 처음으로 성숙 코호트 기준의 전환 구조를 읽을 수 있습니다.

단계	환자 수	이전 단계 대비	초진 대비
추적 완료 초진	34명	-	100.0%
재진 도달	29명	85.3%	85.3%
삼진 도달	18명	62.1%	52.9%
4회 이상 도달	15명	83.3%	44.1%

가장 큰 누수는 재진에서 삼진 사이입니다

초진 34명 중 29명이 재진해 첫 재방문 장벽은 잘 넘습니다. 그러나 재진 환자 29명 가운데 삼진까지 간 환자는 18명으로 11명이 이탈합니다. 초진 대비로는 재진 85.3%에서 삼진 52.9%로 32.4%p 하락합니다. 반면 삼진 18명 중 15명은 4회 이상으로 이어져, 삼진 이후의 유지력은 상대적으로 안정적입니다.

실행 지점

초진 상담을 전면 수정하기보다 2회차 종료 시점에 호전 확인, 남은 치료 목표, 예상 횟수, 다음 방문일을 명확히 제시하는 것이 효율적입니다. 다음 30일 목표는 성숙 코호트 삼진율 60% 이상입니다.

치료별 전환은 아직 탐색 수준

초진 당일 치료	n	재진율	삼진율	해석
약침	18	83.3%	50.0%	전체와 유사
일반진료	8	75.0%	50.0%	표본 적음
추나+약침	6	100.0%	50.0%	표본 적음
추나	2	100.0%	100.0%	판단 불가

초진 당일 특정 시술이 전환을 높인다고 단정할 표본은 없습니다. 시술 여부보다 질환, 중증도, 원장, 예약 확정 여부를 함께 기록해야 실제 요인을 분리할 수 있습니다.

03 매출 · 단가가 아니라 진료량 문제

최신 독립 30일 비교에서 총진료비는 6,085만원에서 5,037만원으로 1,048만원 감소했습니다. 건당 평균 진료비가 상승했는데도 총액이 줄었으므로 가격 하락이 원인이 아닙니다.

지표	최근 30일	이전 30일	변화
총진료비	50,373,310원	60,854,930원	-17.2%
진료일당	2,014,932원	2,434,197원	-17.2%
진료 1건당	59,543원	58,627원	+1.6%
환자 1명당	200,690원	213,526원	-6.0%
비급여 비율	24.7%	17.2%	+7.5%p

매출 감소를 세 부분으로 분해하면

- 1. 환자 수: 최신 환자 수는 총진료비와 환자당 진료비를 기준으로 약 251명, 이전은 약 285명으로 추정되어 약 12% 줄었습니다.
- 2. 환자당 방문: 3.92회에서 3.73회로 4.8% 감소해 환자당 가치가 낮아졌습니다.
- 3. 건당 단가: 1.6% 상승해 일부 방어했지만, 진료량 감소를 상쇄하기에는 작았습니다.

경영 판단

비급여 비율 24.7%와 건당 진료비 5.95만원은 방어되고 있습니다. 약침·추나 판매를 더 밀어 단가를 높이는 것보다 환자 수와 치료 회차를 회복하는 편이 우선입니다.

주차별 변동

주차	환자/일	초진/일	진료비/일	건당
31주	35.3	3.0	171만원	49,851원
32주	35.2	4.8	212만원	62,135원
33주	39.6	4.6	244만원	63,163원
34주	34.5	4.2	230만원	67,425원
35주	36.0	4.0	130만원	46,346원

35주차는 부분 주차일 가능성이 있고 성숙 코호트도 적으므로 저점 자체를 추세로 단정하면 안 됩니다. 다만 33주차 외에는 환자량이 34~36명대에 머물러 기본 진료량이 낮아졌다는 판단은 유지됩니다.

04 원장·치료 구성 · 근무일 보정이 우선

8월 8일 리포트는 김상준 원장의 재진 풀이 아직 성숙 중이며 향후 전체 진료량의 5~9% 회복 여지가 있다고 보았습니다. 최신 데이터에서도 김 원장의 환자당 방문과 전환율이 허 원장보다 낮지만, 실제 근무표가 다르므로 총량 차이를 곧바로 원장 역량 차이로 해석하면 안 됩니다.

원장	정기 휴진	진료	환자당 방문	재진율	삼진율
허진혁	목요일 오후	635	3.51회	81.4%	54.2%
김상준	화요일 전일	278	3.02회	66.0%	40.4%

화요일은 김상준 원장이 전일 휴진이고, 목요일 오후에는 허진혁 원장이 휴진합니다. 화요일 24.8건과 목요일 32.8건이라는 낮은 전체 진료량에는 수요뿐 아니라 공급 감소가 섞여 있습니다. 원장 비교와 요일 분석 모두 실제 근무 반일 세션당 환자로 다시 계산해야 합니다.

보정 지표

원장별 진료건수 ÷ 실제 근무 반일 세션 수, 초진 수 ÷ 실제 근무 세션 수, 재진·삼진율을 함께 보십시오. 화요일과 목요일 오후를 일반 진료일과 같은 분모로 놓으면 원장 비교와 요일 수요가 모두 왜곡됩니다.

추나·약침

지표	최근	이전	변화	판정
추나 이용률	22.3%	26.5%	-4.2%p	하락
약침 이용률	67.8%	61.4%	+6.4%p	상승
약침패키지/일	0.5	0.7	-28.6%	기준선 형성 중

추나·약침 장기 증감은 기록 시작 시점 때문에 무효입니다. 최신 비교도 초기 도입 효과가 섞일 수 있습니다. 원장별로 초진 질환, 예약 확정, 21일 내 삼진 도달, 패키지 제안 여부를 함께 기록해야 실제 차이를 분리할 수 있습니다.

05 상병과 운영 · 큰 환자군의 작은 개선

허리·골반과 목이 전체 상병의 59.9%를 차지합니다. 신규 광고 범위를 넓히기보다 이 두 핵심군의 전환과 지역 검색 노출을 개선하는 편이 효과가 큼니다.

부위	비중	초진 n	재진율	삼진율	판단
허리·골반	35.1%	34	70.6%	47.1%	물량 크고 전환 개선 여지
목	24.8%	27	88.9%	40.7%	2회차 이후 이탈
무릎	9.7%	5	100.0%	80.0%	좋으나 표본 적음
어깨	9.3%	11	72.7%	54.5%	관찰
팔꿈치	3.5%	9	55.6%	33.3%	설명·예후 점검

운영 병목

요일	진료/일	운영 해석
월	48.5	최고 혼잡
금	43.4	혼잡
수	38.5	중간
목	32.8	허 원장 오후 휴진 영향
토	28.3	9시 집중
화	24.8	김 원장 전일 휴진 영향

평일은 9시 232명, 10시 115명, 14시 108명에 집중되고 12시 20명, 13시 54명으로 낮습니다. 다만 화요일과 목요일의 낮은 총량은 정기 휴진으로 공급이 줄어든 결과가 섞여 있으므로 수요 부족으로 단정할 수 없습니다. 월·금 오전의 실제 대기시간을 측정하고 원장별 반일 세션당 환자를 함께 봐야 합니다.

운영 원칙

야간 진료를 바로 확대하기보다 4주간 대기시간을 함께 측정하십시오. 혼잡 시간의 실제 대기가 길면 인력·베드 배치를 조정하고, 대기가 짧다면 시간대 편차는 수요 특성일 뿐 병목이 아닐 수 있습니다.

지역 전략의 유지와 수정

8월 8일 리포트가 제시한 휴면환자 리콜, 인접 경쟁자 대비 시인성, 아파트 단지 밀착, 지역+시술 검색어 전략은 여전히 타당합니다. 다만 최신 성숙 코호트에서 치료 전환이 측정되기 시작했으므로, 외부 유입 활동과 동시에 2회차 이후 완주율을 관리해야 합니다. 유입만 회복하고 삼진 전환이 낮으면 총진료량 회복은 제한됩니다.

06 9월 운영 캘린더와 주변 경쟁

9월에는 추석 주간 한 주 전체를 휴진할 예정입니다. 따라서 다음 달 월간 합계와 전월 대비 수치는 구조적으로 낮아집니다. 휴진 영향을 제거하지 않으면 환자 감소나 매출 악화로 잘못 판단하게 됩니다.

항목	운영 조건	분석 반영
김상준 원장	매주 화요일 휴진	화요일 총량과 원장별 세션 수 보정
허진혁 원장	매주 목요일 오후 휴진	목요일 총량과 반일 세션 보정
추석 주간	전 주간 전체 휴진	월 합계 비교 금지, 진료일당·세션당 비교

추석 전후에 봐야 할 지표

휴진 직전에는 예약이 물리고 휴진 직후에는 미뤄진 환자가 일시적으로 증가할 수 있습니다. 주차별 선 그래프만 보면 급락 뒤 급반등처럼 보이므로, 9월은 실제 진료일당 환자, 원장별 세션당 환자, 영업일당 진료비를 기본 지표로 사용하십시오. 8월 36.1명과 비교할 때도 월 합계가 아니라 이 기준을 맞춰야 합니다.

최근 주변 개원 확인

기관	위치	개원 확인	본원 영향
혜성한의원	다대로 423, 낫개역 앞	2025-09-24	다대동 내 최신, 즉시 인접 아님
다대동의한의원	다대로 680	2022-06-20	본원과 가장 가까운 최근 경쟁자
2026년 신규	다대포역·다대로 698 인접권	확인되지 않음	현재로서는 신규 진입 신호 없음

2026년 8월 29일 현재 공개 검색과 지도에서 다대포역 인접권의 새로운 한의원은 확인되지 않았습니다. 혜성한의원은 현재 지도상 다대로 423 1층, 낫개역 6번 출구 인근으로 표시됩니다. 기존 공식 개설효자의 2025년 9월 24일 개원 기록과 결합하면 다대동에서 가장 최근 확인되는 개원이지만, 본원 바로 옆 상권은 아닙니다.

판정 한계

지도 등록이 늦거나 개설 신고 후 아직 노출되지 않은 기관은 빠질 수 있습니다. 따라서 ‘2026년 신규 개원이 절대 없다’가 아니라 현재 공개자료에서 확인되지 않는다고 표현하는 것이 정확합니다. 다대로 692 공실 재입점 여부는 계속 현장 확인할 가치가 있습니다.

07 다음 30일 실행안

목표는 2024년의 57~62명이 아니라 현재 경쟁 조건에서 먼저 40명대 초반을 회복하는 것입니다. 단, 추석 주간 전체 휴진 때문에 9월 월합계 목표는 사용하지 않고 실제 진료일·세션 기준으로 평가합니다.

우선	실행	측정지표	30일 기준
1	초진 유입경로 5분류 기록 네이버·소개·휴면·지역노출·기타	초진/일, 채널별 n	4.2 → 4.7 이상
2	2회차 종료 시 치료계획·다음 예약 확정	성숙 코호트 삼진율	52.9% → 60%
3	90~180일 휴면환자부터 적법 범위 내 경과 확인	연락 n, 예약 n, 실제 내원 n	응답률·내원률 기준선 확보
4	원장별 동일 질환 전환 비교와 상담 프로토콜 통일	원장별 재진·삼진 격차	격차 축소 여부
5	원장별 실제 근무 반일 세션을 기록해 총량 보정	세션당 환자·초진·진료비	근무일 왜곡 제거

판정 대시보드

지표	현재	회복 신호	경고 신호
진료환자/일	36.1	40 이상	36 미만 지속
초진/일	4.2	4.7 이상	4.2 미만
성숙 재진율	85.3%	80% 이상 유지	75% 미만
성숙 삼진율	52.9%	60% 이상	50% 미만
환자당 방문	3.73	3.9 이상	3.7 미만
진료비/일	201만원	225만원 이상	200만원 미만

최종 평가

경희홍익한의원은 진료 단가와 첫 재방문 능력이 무너진 상태가 아닙니다. 8월 말의 약 점은 유입량과 치료 지속 회차입니다. 9월에 초진 4.7명, 진료환자 40명, 성숙 삼진율 60% 중 두 가지 이상을 달성하면 여름의 일시적 저점으로 볼 수 있습니다. 반대로 진료 환자 36명대가 지속되면 경쟁·노출·휴면환자 이탈을 별도 조사해야 합니다.

자료와 한계

비교자료: ‘경희홍익의원 월간 진료 리포트 2026-08’(분석 기간 2026-07-10~08-08) 및 최신 30일 집계(2026-07-30~08-28). 최신 진료비·상병코드 보 유율은 92.7%, 진료시간 미확인은 0건입니다. 금액 평균은 진료비 데이터 보유 방문 기준입니다. 두 비교창은 10일 중첩됩니다. 추나·약침은 2026년 7 월 전후 기록 시작 영향이 있어 장기 증감 판단에서 제외했습니다. 원장별 차이는 질환·요일·초진 배정의 교란을 통제하지 않은 관찰값입니다.